



SESSION 2026

Guide Méthodologie EVC 2026

Voie interne (QCM) & voie externe (EVCF / EVCP)

+9 000

médecins
accompagnés

**Toutes les
spécialités**

sont couvertes

**15
ans**

d'expertise
EVC / PAE

Le contexte : aux EVC, d'après les données du CNG, le taux de réussite moyen toutes spécialités est d'environ 15 %.

La préparation va donc faire la différence pour réussir dans les meilleures conditions !

LA MÉTHODE QUE NOUS ENSEIGNONS À NOS CANDIDATS PADHUE DEPUIS 2011



major-ecn.fr

PARTIE 1**Pourquoi la méthodologie **change tout** aux EVC**

« Nos candidats n'échouent pas par manque de connaissances médicales. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais appris à répondre selon le format que le jury attend. C'est exactement ce que nous corrigeons. »

— L'équipe pédagogique Major ECN

Chaque session, le même scénario se répète : des praticiens avec dix ou quinze ans d'expérience clinique échouent aux EVC, tandis que de jeunes lauréats, récemment thésés, réussissent du premier coup. Ce n'est pas une question de compétence médicale — c'est une question de méthode.

Les EVC ne sont pas un examen de connaissances pures. C'est un concours sélectif, avec un format de réponse très codifié, une grille de correction précise, et des réflexes attendus par le jury que rien dans la pratique clinique quotidienne ne t'enseigne.

✓ À RETENIR — LE PRINCIPE À RETENIR

Aux EVC, le plus difficile n'est généralement pas de savoir — c'est de ne rien oublier, dans le bon format, dans le temps imparti. La méthode est ce qui transforme des connaissances solides en points effectivement obtenus.

Pourquoi l'expérience seule ne suffit pas : les biais cognitifs du diagnostic

Il existe une explication documentée au paradoxe évoqué plus haut. Le Dr Pat Croskerry, urgentiste et chercheur de référence sur l'erreur diagnostique, a montré qu'un clinicien expérimenté raisonne en grande partie par reconnaissance de motifs (pattern recognition) : une perception quasi instantanée, très efficace au quotidien, mais plus vulnérable à certains biais lorsque le temps manque ou que le stress augmente — deux conditions réunies pendant un concours.

Trois biais reviennent particulièrement dans la littérature sur l'erreur diagnostique :

- **La clôture prématurée** (premature closure) — l'erreur de raisonnement la plus fréquemment rapportée : accepter un diagnostic dès qu'il semble plausible, sans poursuivre l'exploration des hypothèses alternatives.
- **Le biais d'ancrage** — rester fixé sur l'hypothèse initiale et ne pas la réviser malgré l'arrivée d'informations qui la contredisent.
- **Le biais de confirmation** — ne retenir, parmi les données de l'énoncé, que celles qui confortent le diagnostic déjà envisagé, en minimisant les éléments discordants.

■ STRATÉGIE — LA PARADE LA MIEUX DOCUMENTÉE

Plusieurs travaux convergent sur un point : forcer systématiquement la génération d'au moins un diagnostic différentiel avant de conclure est l'une des stratégies les plus robustes contre ces biais (Bowen, New England Journal of Medicine, 2006 ; Croskerry, Academic Medicine). C'est précisément ce que vise le 6e axe de la méthode diagnostique présentée dans la partie suivante : il ne s'agit pas d'une case à cocher pour faire bonne mesure, c'est l'étape qui te protège le plus efficacement d'une erreur de raisonnement sous pression de temps.

Les deux voies, en un coup d'œil

	Voie externe	Voie interne
Public	PADHUE résidant à l'étranger ou exerçant en France depuis moins de 2 ans	PADHUE exerçant en France depuis 2 ans révolus
Format	2 épreuves écrites de 2h : EVCF + EVCP	1 épreuve unique de 2h, QCM
Type de réponse	Questions à réponse ouverte courte (QROC), cas cliniques	QRU et QRM
Ce qui est testé	Raisonnement clinique rédigé, justification	Rapidité, rigueur de lecture, gestion du barème

La session EVC en un coup d'œil



Les 3 biais cognitifs du diagnostic sous pression

CONCOURS EVC — Temps limité + stress + pression du résultat

Deux conditions qui activent le raisonnement heuristique rapide, vulnérable aux biais

1

Clôture prématurée

Accepter le premier diagnostic plausible sans poursuivre l'exploration des hypothèses alternatives.

2

Biais d'ancrage

Rester fixé sur l'hypothèse initiale et refuser de la réviser malgré les données contradictoires.

3

Biais de confirmation

Ne retenir que les données qui confortent le diagnostic envisagé, en minimisant les autres.

Ces 3 biais se renforcent mutuellement — voir Partie 1 pour l'explication complète

LA PARADE — AXE 6 DE LA MÉTHODE DIAGNOSTIQUE

Forcer systématiquement au moins 1 diagnostic différentiel avant de conclure

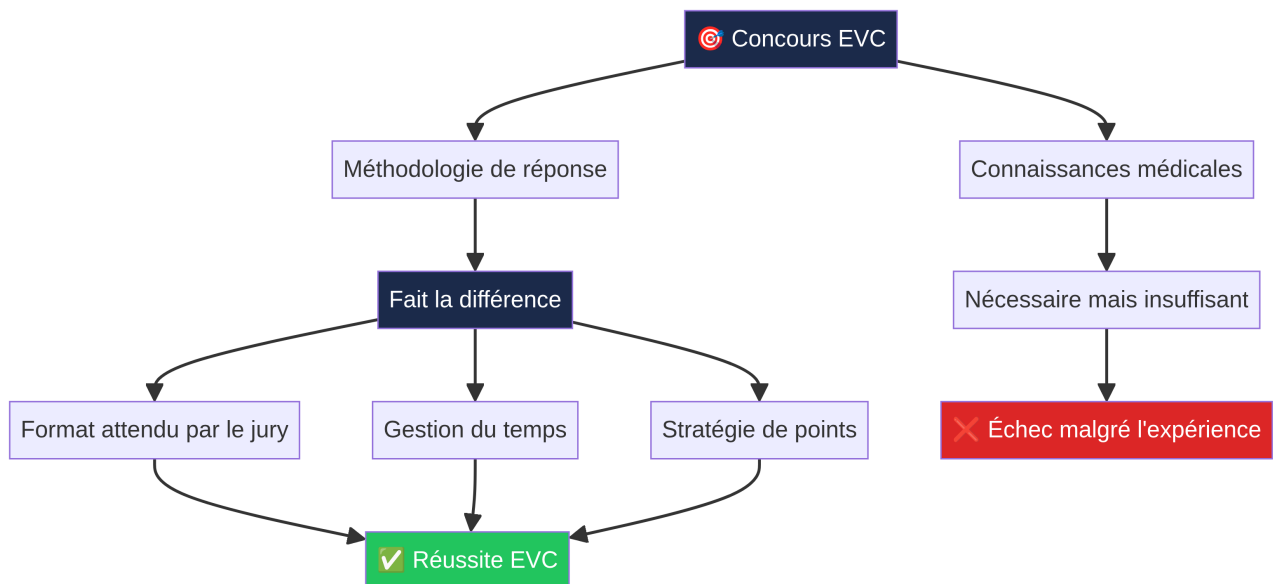


Schéma — Pourquoi la méthode fait la différence aux EVC

■ **MAJOR ECN — PENDANT QUE TU LIS CE GUIDE, D'AUTRES CANDIDATS S'ENTRAÎNENT**

Chez Major ECN, nous préparons des candidats aux deux voies dans plus de 45 spécialités. Ce que 15 ans nous ont appris : les candidats qui réussissent ne sont pas forcément les mieux formés au départ. Ce sont ceux qui ont compris le plus tôt comment le jury note — et qui s'y sont entraînés activement. Les épreuves approchent. Chaque semaine compte. Commence dès aujourd'hui sur major-ecn.fr



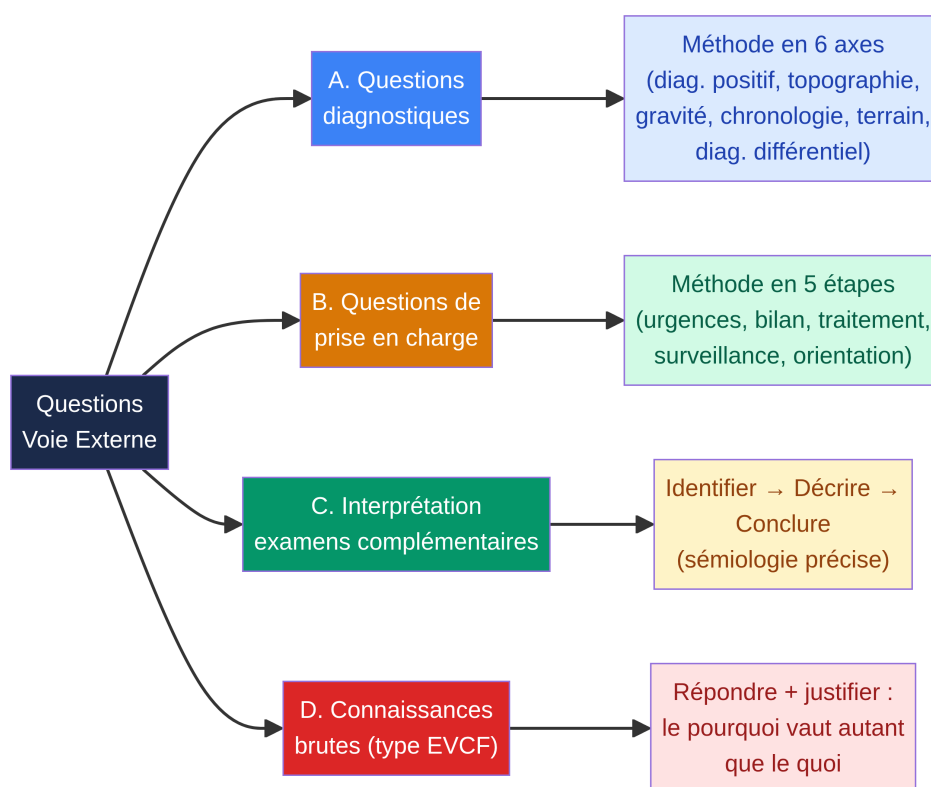
PARTIE 2**Voie externe : les 4 familles de questions**

Schéma — Les 4 familles de questions de la voie externe

Quelle que soit ta spécialité, les questions de la voie externe se répartissent en 4 grandes familles. Une fois que tu reconnais à quelle famille appartient une question, tu sais exactement quelle structure de réponse appliquer.

A. Les questions diagnostiques

Elles évaluent ta capacité à poser un diagnostic complet à partir des données fournies. Un diagnostic juste mais incomplet ou mal qualifié perd des points, même s'il est dans le bon sens.

La méthode en 6 axes

1

Diagnostic positif

Le nom précis de la pathologie

2

Topographie / sous-type

Localisation ou forme clinique

3

Stade de gravité

Signes de gravité, complications

4

Chronologie

Aigu, chronique, récurrent, évolutif

5

Terrain

Antécédents, comorbidités, âge, contexte

6

Diagnostic différentiel

Ce que tu élimines, et pourquoi — le plus oublié !

✓ TIP — TIP PRATIQUE

L'ordre des 6 axes importe peu, tant que chaque élément apparaît dans ta réponse finale. Le 6e axe — le diagnostic différentiel — est souvent le plus oublié, et c'est pourtant lui qui distingue une copie moyenne d'une copie qui rapporte tous les points (voir Partie 1 : c'est aussi l'axe qui te protège le plus efficacement des biais de raisonnement sous pression de temps).

EXEMPLE — VOIE EXTERNE, MÉDECINE GÉNÉRALE

Énoncé : Femme de 34 ans, sans antécédent, consulte pour une douleur de la fosse iliaque droite apparue il y a 18 heures, initialement péri-ombilicale puis localisée. Elle présente une fièvre à 38,2°C, des nausées, et une défense localisée en fosse iliaque droite à la palpation. Bilan biologique : hyperleucocytose à 14 000/mm³ à prédominance neutrophile, CRP à 45 mg/L. Bêta-HCG négatif.

Réponse attendue : Appendicite aiguë (diagnostic) non compliquée à ce stade (gravité), d'évolution récente sur 18 heures avec migration de la douleur typique (chronologie), chez une patiente jeune sans antécédent (terrain), bêta-HCG négatif éliminant une grossesse extra-utérine (diagnostic différentiel écarté).

B. Les questions de prise en charge

Elles évaluent ta capacité à organiser des soins, pas seulement à citer un traitement. L'erreur la plus coûteuse est d'oublier une mesure indispensable ou de proposer un geste dangereux compte tenu du contexte.

La méthode en 5 étapes

- **Mesures immédiates / urgence** — ce qui doit être fait avant tout, sans attendre de bilan
- **Bilan complémentaire** — examens cliniques et paracliniques utiles à la décision
- **Traitement étiologique et symptomatique** — molécule, dose, voie, durée si tu les connais
- **Surveillance** — paramètres à suivre pour juger de l'efficacité et de la tolérance
- **Orientation** — le patient reste-t-il hospitalisé, rentre-t-il, faut-il un avis spécialisé ?

✗ PIÈGE — PIÈGE FRÉQUENT

« Quelle est votre prise en charge ? » n'est pas la même question que « quel est votre traitement ? ». La prise en charge englobe les mesures immédiates, le bilan et l'orientation — pas seulement la prescription.

✓ ASTUCE — ASTUCE

Adapte toujours ta réponse aux moyens réellement disponibles dans le contexte donné par l'énoncé : un médecin généraliste en cabinet, un urgentiste en centre hospitalier périphérique et un réanimateur en CHU n'ont pas les mêmes ressources immédiates.

C. Les questions d'interprétation d'examens complémentaires

Fréquentes dans toutes les spécialités — biologie en médecine générale, imagerie en chirurgie ou en pneumologie, gazométrie et échographie en réanimation. Impossible de faire l'impasse, quelle que soit ta spécialité.

- **Identifier l'examen** — type, modalité, paramètre observé
- **Décrire avec un vocabulaire sémiologique précis** — pas d'approximation, pas de terme de tous les jours
- **Conclure** — relier l'observation à un diagnostic compatible avec le contexte clinique

EXEMPLE — VOIE EXTERNE, BIOLOGIE EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Énoncé : Vous recevez le bilan biologique d'un patient de 58 ans suivi pour une asthénie progressive : hémoglobine 9,8 g/dL, VGM 72 fL, ferritine effondrée à 6 ng/mL, CRP normale.

Réponse attendue : Anémie microcytaire (VGM < 80 fL) par carence martiale (ferritine effondrée), sans syndrome inflammatoire associé (CRP normale) — orientant vers une cause chronique à rechercher en priorité sur le plan digestif chez un homme de cet âge.

D. Les questions de connaissances brutes (type EVCF)

Ce sont des QROC qui semblent simples — mais le piège classique est de répondre sans justifier, alors qu'une grille de correction valorise presque toujours le « pourquoi », pas seulement le « quoi ».

✗ PIÈGE — PIÈGE FRÉQUENT

À l'opposé, ne tombe pas dans la « réponse fleuve » : étaler un maximum de connaissances dans l'espoir d'accrocher quelques mots-clés est une stratégie de candidat sans méthode. Une réponse trop longue dilue les mots-clés attendus et fait perdre du temps précieux.

✓ À RETENIR

Une réponse binaire « OUI » ou « NON » doit systématiquement être justifiée. Une réponse juste mais non justifiée est souvent notée à moitié, voire moins.

■ MAJOR ECN — CE GUIDE T'EXPLIQUE COMMENT NOS FORMATIONS TE FONT PRATIQUER JUSQU'À MAÎTRISER

Lire une méthode et l'appliquer sous 2h de pression sur un vrai cas, ce n'est pas la même chose. Nos candidats s'entraînent sur des centaines de QROC et cas cliniques calibrés au niveau réel des EVC — avec correction détaillée pour savoir exactement ce que le jury attendait. Chaque cas réalisé avec nous est une erreur en moins le jour J. → major-ecn.fr

PARTIE 3

Structurer une copie qui rapporte des points

Au-delà du contenu médical, la présentation matérielle de ta copie influence directement la vitesse et la qualité de la correction — un correcteur qui traite des centaines de copies récompense la clarté.

- Numérote tes réponses en suivant exactement l'ordre des sous-questions posées
- Utilise des tirets ou des puces plutôt que des paragraphes denses pour les listes de mesures
- Mets en évidence les mots-clés attendus (diagnostic, molécule, paramètre de surveillance) en début de ligne
- Ne laisse jamais une sous-question sans réponse — une réponse partielle vaut toujours mieux qu'une absence de réponse
- Gère ton temps par sous-question plutôt que par dossier entier, pour ne pas sacrifier les questions suivantes

Gestion du temps — ce que les vrais sujets montrent

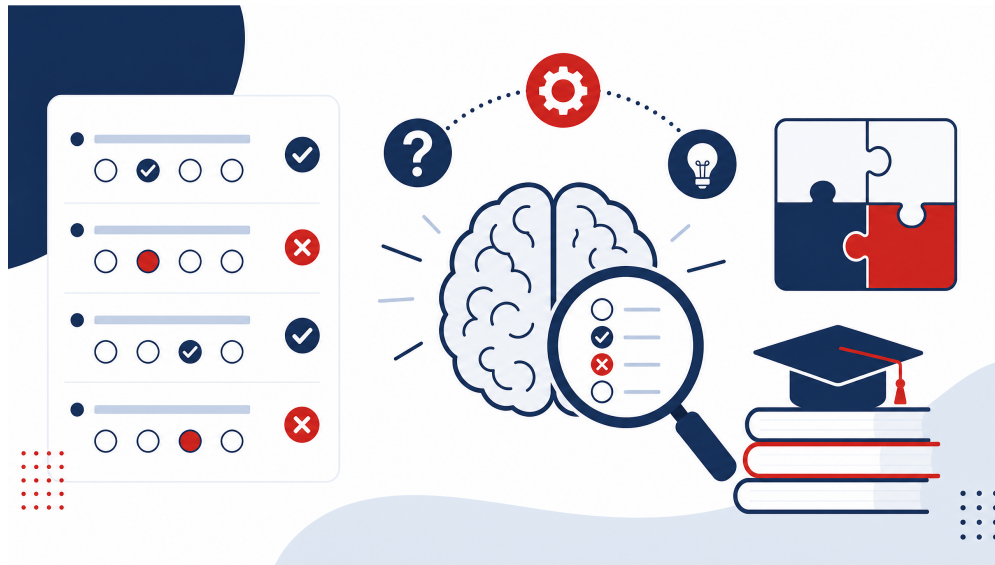
■ À SAVOIR — STRUCTURE RÉELLE VARIABLE SELON LA SPÉCIALITÉ ET LA SESSION

La structure exacte des épreuves n'est pas publiée de manière standardisée par le CNG. Elle varie selon la spécialité et peut évoluer d'une session à l'autre. Les chiffres ci-dessous sont indicatifs — basés sur les sujets réels disponibles en médecine générale 2025, à titre d'ordre de grandeur.

Épreuve	Structure observée (MG 2025)	Ordre de grandeur
EVCF (connaissances fondamentales)	4 sujets indépendants chacun avec plusieurs sous-questions	~30 min / sujet (120 min ÷ 4)
EVCP (connaissances pratiques)	4 cas cliniques progressifs chacun avec plusieurs sous-questions	~30 min / cas (120 min ÷ 4)

■ LA RÈGLE QUI NE CHANGE PAS — QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE

Ne sacrifie jamais un sujet entier pour en peaufiner un autre. Dès qu'une sous-question te coûte trop de temps, passe à la suivante — une réponse partielle rapporte toujours plus qu'une absence de réponse. Réserve 5 à 10 minutes en fin d'épreuve pour vérifier qu'aucun item n'est resté sans réponse.

PARTIE 4**Voie interne : comprendre la logique des QCM**

La voie interne repose sur une épreuve unique de QCM — c'est confirmé officiellement par le CNG. Deux formats coexistent, avec des logiques de notation très différentes — les confondre coûte cher.

QRU — Question à Réponse Unique

Une seule réponse exacte attendue — le principe est simple et fait peu de doute.

Réponse cochée	Résultat
La bonne réponse	1 point
Une réponse fausse	0 point
Plusieurs réponses cochées	0 point, quelle que soit la combinaison

QRM — Question à Réponses Multiples

Entre 1 et 5 réponses exactes possibles. Le principe de notation par « discordances » est la convention la plus répandue dans les examens médicaux français à QCM. Il est présenté ici à titre informatif — le mode de notation exact des EVC n'est pas officiellement publié par le CNG, et les barèmes réels peuvent différer selon la session.

Discordances	Points
0 discordance	10 points
1 discordance	5 points
2 discordances	2 points
3 discordances ou plus, ou 1 réponse inacceptable, ou 1 oubli indispensable	0 point

✓ À RETENIR — LE RÉFLEXE QUI COMPTE VRAIMENT

Aux EVC comme dans tout examen médical à QCM : cocher une réponse clairement dangereuse pour le patient ou oublier une mesure clairement indispensable pèse bien plus lourd qu'une simple imprécision. C'est cette hiérarchie clinique qui doit guider ta sélection : en cas de doute sérieux sur un item, mieux vaut s'abstenir que cocher au hasard.

EXEMPLE — QRM, VOIE INTERNE — ENTRAÎNE TON RAISONNEMENT CLINIQUE

Énoncé : Devant un syndrome confusionnel aigu chez un patient de 78 ans hospitalisé depuis 3 jours, quelles mesures proposez-vous en première intention ?

Items : A) Recherche systématique d'un globe vésical ou d'un fécalome (indispensable) — B) Réévaluation de l'ensemble des traitements en cours (indispensable) — C) Contention physique systématique (inacceptable) — D) Dosage de la natrémie (correcte) — E) Benzodiazépine systématique en première intention (inacceptable)

Le raisonnement à retenir : coché A + B + D, tu maximises ta note. Oublier D est une imprécision. Cocher C ou E, des items dangereux pour le patient, c'est une erreur grave que le jury sanctionne systématiquement. C'est cette hiérarchie clinique qui doit guider ta sélection.

Réflexe de sélection en QRM — l'arbre de décision

Pour chaque item proposé, je me pose ces questions :



Est-ce clairement **INACCEPTABLE** pour le patient ?

OUI → Ne coche PAS

Risque éliminatoire



Est-ce clairement **INDISPENSABLE** à la prise en charge ?

OUI → Coche OBLIGATOIREMENT



Je suis en **DOUTE** sur cet item

DOUTE → S'abstenir plutôt que risquer



Item sûrement **CORRECT**

OUI → Coche SANS HÉSITER

✓ LE RÉFLEXE À ANCRER

Inacceptable ? Ne jamais cocher. Indispensable ? Toujours cocher. En doute ? Abstiens-toi. Sûrement correct ? Coche sans hésiter.

PARTIE 5

Les pièges de lecture les plus coûteux

En QCM comme en QROC, une grande partie des points perdus ne vient pas d'un manque de connaissances, mais d'une mauvaise lecture de l'énoncé, sous la pression du temps.

- **La double négation** — « Quels gestes ne sont pas contre-indiqués ? » revient à demander quels gestes sont autorisés. Reformule mentalement la question avant de répondre.
- **Le « sauf » ou le « à l'exception de »** — change complètement le sens d'une consigne par ailleurs simple.
- **Singulier vs pluriel** — « quelle est LA réponse exacte » (QRU) n'est pas « quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) exacte(s) » (QRM). Lis toujours l'intitulé du format avant de répondre.
- **Les qualificatifs absolus** — « toujours », « jamais », « systématiquement » rendent souvent une proposition fausse en médecine, où il existe presque toujours une exception.
- **Le terrain implicite** — un énoncé qui précise « grossesse », « insuffisance rénale » ou « sujet âgé » modifie la réponse attendue, même si la question semble générale.

✓ MÉTHODE — MÉTHODE DE LECTURE EN 3 PASSAGES

1er passage : lis l'énoncé en entier sans regarder les propositions, pour te faire ta propre idée.
 2e passage : élimine les propositions certainement fausses. 3e passage : pèse les propositions restantes une à une, en te demandant spécifiquement « est-ce indispensable ? » et « est-ce inacceptable ? » avant de cocher.

■ INFO — POURQUOI S'ENTRAÎNER SUR DU CONTENU SPÉCIFIQUEMENT CALIBRÉ EVC

Les QCM conçus pour les étudiants en formation initiale (type EDN) évaluent un autre niveau d'exigence que celui attendu d'un médecin déjà thésé. S'entraîner uniquement sur du contenu non calibré EVC — quelle que soit la spécialité — crée un faux sentiment de préparation. Les EVC évaluent un médecin déjà thésé, pas un étudiant en formation initiale : le niveau d'exigence attendu est différent.

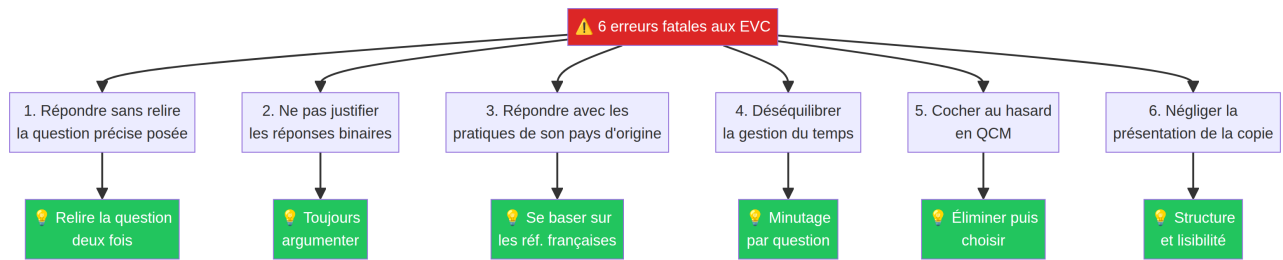
PARTIE 6**Les 6 erreurs qui font perdre le plus de points**

Schéma — Les 6 erreurs les plus coûteuses et leurs solutions

1 Répondre sans relire la question précise posée

Réciter ce que l'on sait sur un thème, plutôt que de répondre exactement à la question formulée. Deux questions proches sur le même thème peuvent attendre des réponses très différentes.

2 Ne pas justifier les réponses binaires

Une réponse « OUI » ou « NON » non justifiée est généralement sous-notée, même si elle est juste sur le fond.

3 Répondre avec les pratiques de son pays d'origine

Les EVC évaluent la pratique médicale telle qu'elle est codifiée par les recommandations françaises en vigueur (HAS, sociétés savantes), pas les habitudes acquises ailleurs.

4 Déséquilibrer la gestion du temps

Passer 25 minutes sur une question pour gratter 2 points supplémentaires, au prix de questions suivantes laissées vides, est une des erreurs les plus coûteuses statistiquement.

5 Cocher au hasard en QCM

Sur une QRM, cocher une proposition incertaine sans raisonnement augmente le risque de tomber sur une réponse inacceptable, qui ramène la note de la question entière à zéro.

6 Négliger la présentation de la copie

Une réponse juste mais illisible, non numérotée, ou noyée dans un paragraphe dense, ralentit le correcteur et augmente le risque de perdre des points par simple omission de lecture.

■ **MAJOR ECN — CES ERREURS, NOS FORMATEURS LES REPÈRENT EN 2 SEMAINES — AVANT QU'ELLES NE TE COÛTENT TON CONCOURS**

Ces erreurs sont invisibles quand on se corrige soi-même. Nos formateurs les identifient dans les premières semaines et te permettent de les corriger avant le jour J. Chaque semaine de préparation seule où tu reproduis les mêmes erreurs sans le savoir, c'est une semaine perdue. Évalue ton niveau maintenant sur major-ecn.fr



CAS PRATIQUE — SUJET RÉEL EVC 2024 · EVCP MÉDECINE GÉNÉRALE · Question 1.1

La réponse que tu as écrite vs ce que le jury attendait

ÉNONCÉ — EVCP Médecine Générale 2024 (sujet réel)

Un homme de 30 ans vient aux urgences pour un essoufflement depuis début décembre après avoir joué un match de football. Il a déménagé récemment. 1,80m, 80 kg. Tabagisme actif 10 cig/jour. Antécédent d'asthme dans l'enfance sans traitement de fond depuis.

Question 1.1 : Que recherchez-vous à l'examen pour orienter le diagnostic ?



✗ Réponse incomplète

Ce que beaucoup de candidats écrivent

« À l'auscultation, je recherche des sibilants diffus bilatéraux et un allongement du temps expiratoire. Je vérifie la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. »

Ce qui manque :

✗ INTERROGATOIRE HORS CRISE

→ complètement absent

✗ ANTÉCÉDENTS ATOPIQUES

→ non mentionnés

✗ VARIABILITÉ DES SYMPTÔMES

→ absente

✗ EFFICACITÉ BRONCHODILATATEURS

→ non recherchée

✗ DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

→ aucun signe d'élimination

Ce qui n'est pas écrit n'existe pas pour le jury.

✓ Ce que le jury attendait

Correction Major ECN — sujet réel 2024

① À L'INTERROGATOIRE — hors période d'aggravation

- Toux, sifflements, oppressions thoraciques (pour l'asthme) ; expectorations abondantes et purulentes (pour les diag. différentiels)
- Caractère variable, prédominance nocturne / réveil
- Présence de périodes d'exacerbation
- Efficacité des bronchodilatateurs de courte durée
- ATCD atopique : rhinite allergique, eczéma, dermatite atopique, asthme familial

② À L'EXAMEN CLINIQUE — en faveur + élimination diag. différentiels

En faveur :

- Fièvre
- Toux et expectorations purulentes
- Anomalies auscultatoires, notamment sibilants

Absence d'anomalies (éliminer les diag. différentiels) :

- Pas de foyer crépitant, crépitants diffus, ni baisse localisée du murmure vésiculaire (élimine pneumonie)
- Pas d'œdèmes des membres inférieurs ni signes de TVP (élimine embolie pulmonaire)

RAPPEL ÉNONCÉ — Même patient (homme 30 ans, asthme, EVC 2024)

Question 1.2 : Quels seraient les signes de gravité ?

✗ Réponse incomplète

Ce que beaucoup de candidats écrivent

« Cyanose des extrémités, fréquence respiratoire élevée, saturation basse, troubles de la conscience. »

Ce qui manque :**✗ SIGNES COMPORTEMENTAUX**

→ parle avec des mots, prostré, agité

✗ PARAMÈTRES PRÉCIS

→ pas de seuils — FR > 30, FC > 120, DEP < 50%

✗ MUSCLES ACCESSOIRES

→ non mentionnés

✗ RESPIRATION ABDOMINALE

→ absente

✗ NORMOCAPNIE

→ signe capital contre-intuitif oublié

✗ SIGNES PRÉTERMINAUX

→ bradypnée, bradycardie absents

Ce qui n'est pas écrit n'existe pas pour le jury.

✓ Ce que le jury attendait

Correction Major ECN — sujet réel 2024

① SIGNES CLINIQUES ET COMPORTEMENT

- Parle avec des mots (et non par phrases complètes)
- Assis et prostré
- Agité
- Utilisation des muscles respiratoires accessoires
- Respiration abdominale
- Cyanose des extrémités

Signes préterminaux :

- Bradypnée, bradycardie
- Troubles de la conscience et défaillance hémodynamique

② PARAMÈTRES MESURÉS

- FR > 30/min
- FC > 120/min
- SpO₂ < 90% en air ambiant
- DEP < 50% de la valeur prédite

▲ Signe contre-intuitif — à connaître absolument :

- Normocapnie ou hypercapnie — si la PaCO₂ est normale ou élevée, le patient s'épuise : signe de gravité majeur
- Signes d'hypercapnie (sueurs, agitation, HTA, céphalées)

PARTIE 7

Ce que la science de l'apprentissage change pour ta préparation

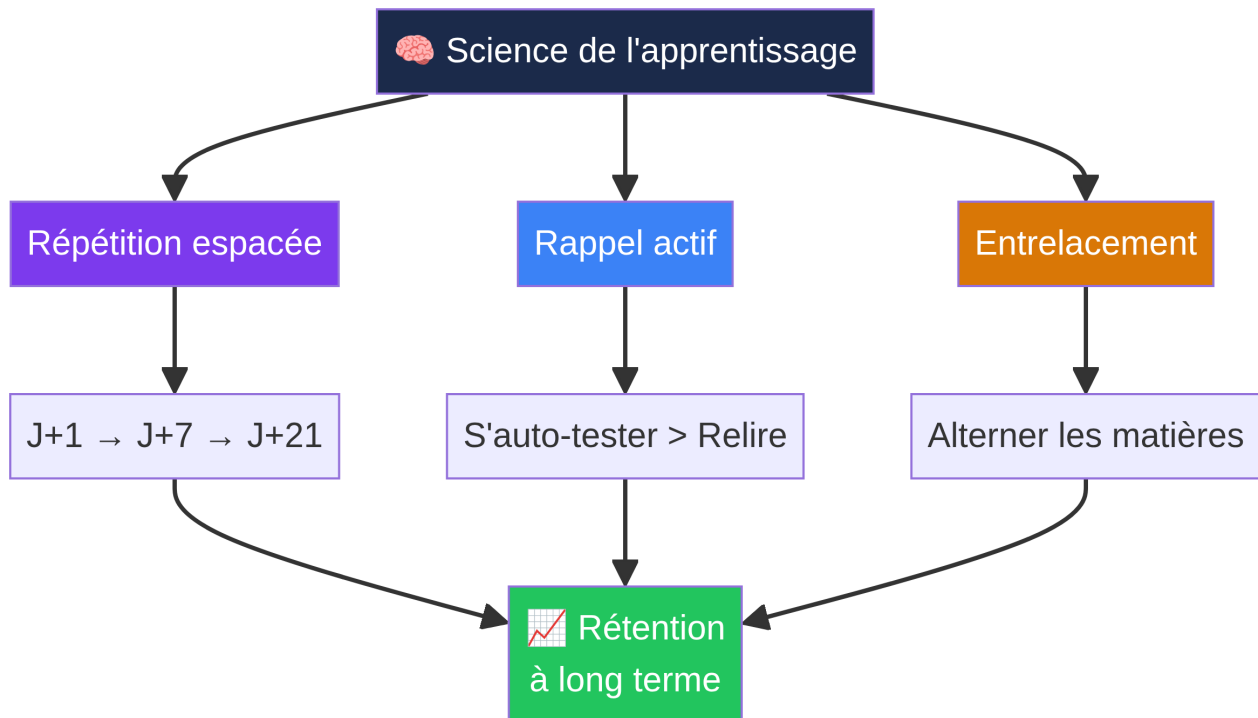


Schéma — Les 3 piliers scientifiques de la rétention à long terme

Au-delà de la méthodologie de réponse, la façon dont tu organises tes sessions de révision a un impact mesuré sur ta rétention à long terme. Trois principes, documentés par la recherche en psychologie cognitive, méritent de structurer ta préparation.

Le rappel actif plutôt que la relecture

Se tester soi-même sur une notion (se demander « qu'est-ce que je sais sur ce thème ? » sans regarder ses notes) ancre durablement l'information, bien davantage que relire un cours plusieurs fois. Ce phénomène, appelé « effet de test » (testing effect) dans la littérature scientifique, a été mis en évidence par de nombreuses études en psychologie cognitive, notamment les travaux de Roediger et Karpicke publiés dans la revue *Psychological Science*.

✓ EN PRATIQUE — COMMENT L'APPLIQUER

Après avoir étudié une fiche ou un cours, ferme le support et essaie de restituer de mémoire les points clés, idéalement sous forme de question ouverte (« quels sont les critères de... ») plutôt que de simple reconnaissance (« est-ce que X fait partie de... »). Les QCM et les QROC d'entraînement sont, par construction, des outils de rappel actif — c'est une raison de plus de privilégier l'entraînement actif à la lecture passive.

La répétition espacée plutôt que le bachotage

Revoir une notion à intervalles progressivement croissants (par exemple le lendemain, puis une semaine après, puis trois semaines après) ancre l'information en mémoire à long terme bien plus efficacement qu'une révision massive et concentrée juste avant l'épreuve. C'est l'un des résultats les plus robustes de la recherche sur l'apprentissage, repris notamment dans la synthèse de référence de Dunlosky et collaborateurs (2013) sur les techniques d'étude les plus efficaces.

L'entrelacement plutôt que le travail en bloc

Alterner plusieurs thèmes au sein d'une même session de révision (plutôt que de passer une semaine entière sur un seul thème) améliore la capacité à distinguer des situations cliniques proches — une compétence directement utile face à des QCM ou des cas cliniques qui mélangent volontairement plusieurs diagnostics différentiels.

■ INFO — CE QUE CELA CHANGE CONCRÈTEMENT POUR TON PLANNING

Plutôt que de traiter une spécialité puis de passer définitivement à la suivante, prévois de revenir régulièrement sur les thèmes déjà étudiés — sous forme de questions, pas de relecture — à intervalles croissants. C'est le principe que suit le planning sur 12 semaines proposé dans la partie suivante.

■ PLATEFORME MAJOR ECN — LA RÉGULARITÉ, IMPOSÉE POUR TOI → [MAJOR-ECN.FR](https://major-ecn.fr)

La plateforme de Major ECN t'impose de la régularité dans tes révisions. Si tu ne travailles pas une journée, elle te le signale immédiatement. Elle génère chaque jour de nouvelles révisions transversales en fonction de ce que tu as déjà travaillé, de tes erreurs et de ton niveau réel — pour que tu travailles les notions qui comptent vraiment. Elle ne t'impose pas un planning fixe, mais elle veille à ce que tu ne perdes jamais le fil. → major-ecn.fr

■ **MAJOR ECN — RAPPEL ACTIF + RÉPÉTITION ESPACÉE : C'EST EXACTEMENT CE QUE TU FAIS CHEZ NOUS**

Nos QCM, QROC et cas cliniques sont structurés pour que tu récupères l'information de mémoire plutôt que de la relire passivement. Et notre programme est conçu pour que tu reviennes sur les thèmes clés à intervalles croissants — sans avoir à gérer cela toi-même. La science est de ton côté. Il faut juste commencer. Chaque jour qui passe sans s'entraîner, c'est un jour que les autres candidats prennent. → major-ecn.fr



PARTIE 8

Ton planning de préparation

Du format idéal à ton échéancier réel

■ POINT DE DÉPART — QUE TU AIES 12 SEMAINES, 6 OU 4 : MÊME LOGIQUE

La durée de préparation change, mais la méthode reste identique. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir tout le temps du monde — c'est de travailler les bons thèmes, dans le bon ordre, avec une correction qui cible tes vraies erreurs. Le format ci-dessous est l'idéal. Plus bas, tu trouveras les versions condensées sur 6 et 4 semaines.

Version idéale — 12 semaines

Semaines	Phase	Contenu
S1–S2	État des lieux	Auto-évaluation · Repérage des thèmes prioritaires · Recommandations de référence
S3–S6	Fondamentaux	Thématiques clés · 1ers QCM/QROC avec correction détaillée
S7–S9	Approfondissement	Situations complexes · Entraînement chronométré · Révision espacée
S10–S11	Entraînement intensif	Séries complètes · Analyse systématique des erreurs
S12	Finalisation	Concours blancs · Fiches de révision · Logistique jour J

Versions condensées — si tu démarres plus tard

Phase	6 semaines	4 semaines
État des lieux	S1 (1 sem.)	J1–J3
Fondamentaux	S2–S3	J4–J10
Entraînement ciblé	S4–S5	J11–J22
Finalisation	S6	J23–J28

Dans tous les cas : priorité aux thèmes les plus fréquemment évalués dans ta spécialité, entraînement actif dès la première semaine, correction de chaque erreur.

■ **PLATEFORME MAJOR ECN — LA RÉGULARITÉ, IMPOSÉE POUR TOI → [MAJOR-ECN.FR](https://major-ecn.fr)**

La plateforme de Major ECN t'impose de la régularité dans tes révisions : si tu ne travailles pas une journée, elle te le signale. Elle comptabilise tes jours travaillés en continu, t'alerte dès que tu décroches et t'indique chaque jour exactement sur quoi mettre l'accent en priorité — en fonction de ta progression, de tes erreurs et de ton niveau réel. Tu gères ton planning selon tes contraintes ; la plateforme veille à ce que tu ne perdes jamais le fil. → major-ecn.fr



PARTIE 9

Les petites voix : gérer le doute sur la durée

85%

des candidats ressentent
le syndrome de l'imposteur

3

états de crise
identifiés et documentables

5

pratiques concrètes
pour préserver la motivation

Il y a un sujet dont aucun guide de préparation ne parle, et qui pourtant fait échouer des candidats compétents : la gestion des pensées d'auto-sabotage sur plusieurs mois de préparation. Pas le stress du jour J — celui-là, on en a parlé. Mais les petites voix qui s'installent semaine après semaine, et qui érodent la motivation avant même d'arriver à l'épreuve.

Les 5 petites voix les plus fréquentes chez les candidats PADHUE

Ces pensées ne sont pas des signaux d'alarme fiables. Ce sont des réactions psychologiques prévisibles face à une situation exigeante et incertaine. Les reconnaître, c'est déjà les désamorcer.

1

« J'ai 15 ans d'expérience, je ne comprends pas pourquoi je dois passer ce concours. »

Ce ressentiment est compréhensible — et partagé par des milliers de candidats. Mais il consomme de l'énergie mentale sans rien changer à la réalité administrative. Les candidats qui réussissent ne trouvent pas le système juste : ils ont simplement décidé de ne pas lui prêter d'énergie le temps de la préparation.

2

« Je bloque sur ce thème depuis une semaine. Je ne suis peut-être pas fait pour ça. »

Bloquer sur un thème prouve que tu travailles, pas que tu es incompetent. Carol Dweck (Stanford) a montré que les personnes qui interprètent un obstacle comme une étape normale d'apprentissage progressent ; celles qui le lisent comme un verdict sur leur incapacité abandonnent. Le blocage est une information sur ce qu'il faut travailler — pas un jugement sur ce que tu es.

3

« J'ai raté mon concours blanc. Je vais encore échouer. »

Un mauvais résultat à un concours blanc est une information utile, pas une prédiction. Kristin Neff (Université du Texas) a montré que se traiter après un échec comme on traiterait un ami dans la même situation — l'autocompassion — améliore la motivation et la résilience bien davantage que l'autocritique dure.

4 « Mon français médical n'est pas aussi fluide que celui des candidats formés ici. »

Ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème d'exposition aux recommandations françaises — et ça, c'est corrigeable. Les correcteurs évaluent le raisonnement clinique et la précision des mots-clés, pas l'élégance stylistique. Un PADHUE qui maîtrise les recommandations HAS et les applique avec clarté a plus de chances de réussir qu'un candidat au français impeccable mais aux connaissances floues.

5 « Tout le monde autour de moi a l'air plus avancé dans sa préparation. »

C'est le syndrome de l'imposteur dans sa version collective — documenté dès 1978 par les psychologues Clance et Imes. Il touche particulièrement les personnes objectivement compétentes qui évoluent dans un environnement où elles se sentent minoritaires. Personne ne voit le travail réel des autres : ce que tu observes, c'est leur façade. Compare-toi à toi-même d'il y a un mois, pas aux autres.

5 pratiques concrètes pour préserver ta motivation sur la durée**1 Note tes progrès, pas seulement tes lacunes**

Chaque semaine, écris deux ou trois choses que tu maîtrisais moins bien il y a un mois et que tu maîtriseras mieux aujourd'hui. Ce n'est pas de la pensée positive — c'est de la mémoire active des progrès réels. Notre cerveau a tendance à sur-pondérer ce qui manque encore par rapport à ce qui est acquis.

2 Fixe-toi des objectifs de processus, pas de résultat

« Réviser 45 minutes ce soir sur les vascularites » est un objectif que tu contrôles entièrement. « Avoir 14/20 à mon prochain concours blanc » ne l'est pas. Les objectifs de processus maintiennent la motivation parce qu'ils peuvent être atteints chaque jour, indépendamment du résultat final.

3 Traite tes erreurs comme un clinicien

Face à une question ratée, pose-toi exactement les mêmes questions qu'en consultation : Qu'est-ce que j'ai raté ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je dois changer dans mon approche ? Un bon clinicien n'a pas honte de ses erreurs diagnostiques — il les analyse. Applique-toi le même standard.

4**Planifie des coupures réelles**

Pas des pauses culpabilisées. De vraies coupures planifiées, sans support de révision, sans culpabilité. La recherche sur la performance cognitive montre que le repos n'est pas une perte de temps : c'est pendant le repos que les connaissances se consolident. Un candidat épuisé en novembre retient moins qu'un candidat reposé.

5**Rappelle-toi pourquoi tu l'as choisi**

Quand la motivation baisse, les raisons d'avoir choisi cette voie sont encore là. Pas la motivation de surface — la raison profonde : exercer librement, stabiliser ta situation professionnelle, continuer à soigner les patients que tu as déjà. Les neurosciences de la motivation montrent que se rappeler le « pourquoi » profond réactive l'engagement même dans les phases difficiles.



"Après une première tentative en solo sans succès, la formation Major ECN m'a apporté la méthode qui a fait la différence."

J'avais tenté de préparer les EVC seule, mais sans succès. D'origine brésilienne, je ne maîtrisais pas encore la méthodologie spécifique attendue en France, ni les réflexes nécessaires pour répondre dans le format de l'épreuve. La formation de Major ECN m'a fait progresser sur tous les plans : la rapidité, la méthodologie, les connaissances ciblées et la confiance en moi. Grâce à cela, j'ai été lauréate et j'ai pu intégrer le système français.

Dr Monica WAITZFELDER

Psychiatrie — Lauréate EVC

Quand c'est plus grave : les 3 états de crise et comment en sortir

Les petites voix dont on vient de parler s'installent progressivement. Mais il existe trois états plus aigus, où l'on ne doute plus — on est convaincu. Ce sont des états psychologiques identifiés et documentables, pas des jugements sur ta valeur ou ta capacité. Et ils ont chacun un protocole de sortie.

État 1 — « Je n'y arriverai pas. C'est au-dessus de moi. »

Ce que tu vis est probablement de la résignation acquise (Seligman, 1975) : après avoir fait des efforts qui n'ont pas semblé porter leurs fruits — un mauvais résultat, une série de questions ratées, une session où rien ne rentre — le cerveau tire une conclusion générale : « quoi que je fasse, ça ne changera rien. » Cette conclusion est fausse. Elle est tirée d'un

échantillon trop petit, dans un moment où les ressources cognitives sont épuisées. Mais le cerveau la prend pour une réalité et arrête d'essayer — même quand les conditions changent.

✓ **PROTOCOLE — SORTIR DE LA RÉSIGNATION ACQUISE : LE SYSTÈME DES PETITES VICTOIRES**

1. Arrête immédiatement ce sur quoi tu échoues. Ne t'acharne pas : chaque échec supplémentaire renforce la conviction d'impuissance. 2. Change de thème ou de type de tâche et choisis quelque chose que tu maîtriseras certainement en 20 minutes. Pas un défi : une petite victoire délibérément facile. Le but est de rétablir le lien « effort → résultat positif » dans ton cerveau. 3. Note ce que tu viens de réussir. Littéralement. La trace écrite ancre la victoire et contre-balance les échecs que tu avais en tête. 4. Reviens au thème difficile le lendemain, pas le même soir.

État 2 — « Il y a trop de contenu. Je ne saurai jamais où commencer. »

Ce n'est pas un problème de quantité de travail. C'est un problème de débordement cognitif : ton cerveau essaie de tenir l'ensemble du programme en tête simultanément, et cette tentative elle-même le sature. Résultat : l'inaction totale, malgré la conscience de l'urgence. Plus tu vois l'amplitude de ce qu'il reste à faire, plus la paralysie s'installe.

✓ **PROTOCOLE — SORTIR DU DÉBORDEMENT COGNITIF : LA RÈGLE DU UN SEUL**

La règle est simple : tu n'as pas un programme à finir ce soir. Tu as une seule chose à faire. Formule ta prochaine action en une phrase précise, avec une durée finie : « Je relis cette fiche sur les critères diagnostiques du lupus pendant 25 minutes, puis je réponds à 5 QCM dessus. » Pas le programme. Pas la session. Pas la semaine. Une seule chose. La vision globale du programme est utile pour planifier. Elle est destructrice quand on est en état de débordement. Ferme les listes, cache le planning, et fais uniquement la prochaine chose.

État 3 — La tétanisation : stress si intense qu'on ne peut plus répondre ni réfléchir

La tétanisation — aussi appelée fusion cognitive dans le champ de la thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT, Hayes et al.) — se produit quand une pensée anxieuse devient si présente qu'elle occupe tout l'espace mental disponible et empêche l'action. On ne « pense » plus : on est fondu dans la pensée. « Je vais échouer » n'est plus une hypothèse, c'est une certitude vécue, et le corps réagit en conséquence (cœur qui s'accélère, impossibilité de lire, blocage total). Cela peut arriver pendant les révisions, mais aussi le jour de l'épreuve elle-même.

✓ PROTOCOLE — PROTOCOLE EN 3 TEMPS POUR SORTIR DE LA TÉTANISATION

Étape 1 — Défuser la pensée (2 minutes). Ne combats pas la pensée. Reformule-la en la nommant : au lieu de « je vais échouer », dis-toi « j'ai la pensée que je vais échouer ». Cette reformulation crée de la distance entre toi et la pensée, sans chercher à l'éliminer. C'est la technique de défusion cognitive de l'ACT : la pensée existe, mais elle n'est plus toi.

Étape 2 — Revenir dans le corps (3 minutes). Cohérence cardiaque : 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration, pendant 3 minutes. C'est un arrêt d'urgence pour le système nerveux autonome, pas une technique de bien-être : elle abaisse physiologiquement le cortisol et redonne accès aux fonctions exécutives.

Étape 3 — La question du médecin (30 secondes). Pose-toi cette question : « Qu'est-ce que je ferais si j'étais un patient devant moi dans cet état ? » La réponse évidente — « je lui dirais de souffler, de reprendre par le début, une question à la fois » — est exactement ce que tu dois appliquer à toi-même.

■ MAJOR ECN — TU N'AS PAS À TRAVERSER CES ÉTATS SEUL(E)

Ces trois états — résignation, débordement, tétanisation — sont exactement ce que nos formateurs détectent et désamorcent au fil des semaines. Nos candidats ne traversent pas ces moments seuls : il y a quelqu'un qui voit où ils en sont, qui recadre, qui remet le cap. La préparation est un marathon, pas un sprint. Mais un marathon sans accompagnement, c'est un risque inutile quelle que soit ta date de départ. Rejoins nos candidats sur major-ecn.fr

PARTIE 10**Check-list finale avant le jour J****J-7**Vérifier administratif
et logistique**J-3**Dernières fiches
de synthèse**J-1**Repos et
cohérence cardiaque**Administratif et matériel**

- ✓ Convocation officielle imprimée et pièce d'identité valide
- ✓ Matériel autorisé selon les indications de la convocation (stylos, montre sans connexion...)
- ✓ Trajet et durée d'accès au centre d'examen anticipés, avec une marge de sécurité
- ✓ Repas et hydratation prévus pour la durée totale de la session si plusieurs épreuves

Méthode

- ✓ Relecture rapide de tes fiches de synthèse des points identifiés comme fragiles
- ✓ Rappel du principe de prudence sur les QRM (s'abstenir plutôt que cocher au hasard en cas de doute) si tu passes la voie interne
- ✓ Rappel des pièges de lecture (double négation, qualificatifs absolus, singulier/pluriel)
- ✓ Répartition de temps prévue par question ou par dossier, gardée en tête avant d'entrer en salle

Gérer le stress le jour J

Le stress n'est pas un défaut à éliminer — à dose modérée, il stimule la concentration. Mais quand il devient envahissant, deux techniques simples et documentées permettent de le réguler rapidement.

- **La cohérence cardiaque** — respire à un rythme régulier d'environ 6 cycles par minute (par exemple : inspiration sur 5 secondes, expiration sur 5 secondes), pendant 5 minutes.

C'est la technique de gestion du stress la mieux documentée scientifiquement : elle abaisse mesurablement le cortisol et ralentit le rythme cardiaque. Pratique-la dans la salle d'attente avant l'épreuve, et en cas de blocage sur une question pendant l'épreuve elle-même.

- **Le recadrage cognitif** — face à une pensée du type « je vais échouer », remplace-la consciemment par une pensée plus réaliste et utile : « je bloque sur cette question, je passe à la suivante et j'y reviendrai si j'ai le temps ». C'est une technique issue des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), simple à mobiliser seul, sans accompagnement.

Mental

- ✓ Une nuit de sommeil correcte prime sur une dernière session de révision tardive
- ✓ Accepter de laisser une question difficile en suspens plutôt que de s'y bloquer
- ✓ Garder en tête que l'objectif est de maximiser les points obtenus, pas de tout savoir parfaitement



MÉMO MÉTHODE — 5 réflexes pour une préparation efficace

1 Réviser quotidiennement

Une session courte chaque jour vaut mieux qu'un marathon la veille. La répétition espacée ancre l'information en mémoire à long terme.

2 Faire des cas cliniques

L'entraînement actif sur de vrais cas calibrés EVC crée les réflexes que la relecture passive ne peut pas construire.

3 Corriger ses erreurs

Analyser chaque erreur comme un clinicien : qu'est-ce que j'ai raté ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je dois changer dans mon approche ?

4 S'entraîner en conditions réelles

Chronométrer ses sessions de révision — la gestion du temps est une compétence à part entière, distincte des connaissances médicales.

5 Relire avant l'épreuve

Réserver 5 à 10 minutes en fin d'épreuve pour vérifier qu'aucune sous-question n'est restée sans réponse : souvent plus rentable que de peaufiner une réponse déjà correcte.

La méthode Major ECN intègre ces 5 réflexes dans chaque session
QCM · QROC · Cas cliniques · Corrections personnalisées → major-ecn.fr

PREUVES SOCIALES

Ils ont réussi avec Major ECN

+9 000

médecins préparés

15 ans

d'expertise EVC/PAE

Toutes

les spécialités couvertes



"Reprendre confiance après un échec — et réussir les EVC avec plus de 17/20 de moyenne."

Lorsque j'ai commencé à préparer les EVC en endocrinologie-diabétologie (2025), je savais que la tâche serait difficile. Dans notre spécialité, seulement deux postes étaient ouverts cette année-là. Les enjeux étaient donc considérables.

Cette réussite a d'autant plus de valeur pour moi que je sortais d'un échec. J'ai rejoint la préparation de Major ECN et j'ai particulièrement apprécié la qualité de l'accompagnement, la disponibilité de l'équipe et le suivi tout au long de la préparation. Les conseils méthodologiques et les corrections m'ont permis de progresser de manière régulière.

Dr SY Ely Cheikh Ibrahima

Endocrinologie-Diabétologie — Lauréat EVC 2025



"Une méthode, un cadre et un accompagnement qui font vraiment la différence — même quand le nombre de postes se réduit."

Avant de commencer ma préparation aux EVC de gériatrie, plusieurs confrères qui avaient réussi les EVC m'avaient parlé de Major ECN. Leurs retours étaient très positifs et, au bout d'un moment, j'ai décidé de leur faire confiance et de m'inscrire à mon tour.

Quelques semaines après le début de ma préparation, nous avons appris une nouvelle qui a été un véritable choc : la réduction très importante du nombre de postes pour la voie externe. Honnêtement, quand j'ai appris qu'il n'y avait plus qu'une trentaine de postes au niveau national, j'ai pris un coup au moral.

Heureusement, j'étais déjà engagé dans la préparation. Les cours continuaient, les enseignants étaient présents et il y avait toujours un objectif à atteindre. Finalement, cela m'a aidé à rester concentré malgré les doutes.

J'ai découvert que les EVC étaient beaucoup plus exigeants que ce que certaines personnes laissent entendre. Avec un nombre de postes aussi limité, chaque point compte. Il faut des connaissances, mais aussi une méthode de travail, de la régularité et beaucoup d'entraînement.

Ce que j'ai particulièrement apprécié chez Major ECN, c'est le fait de savoir exactement sur quoi concentrer mes efforts. Je savais quoi réviser, quand le réviser et comment avancer progressivement.

Avec le recul, je pense sincèrement que sans méthode, sans cadre et sans accompagnement, il m'aurait été beaucoup plus difficile de réussir dès cette première tentative. Aujourd'hui, tous les sacrifices en valaient la peine.

Si je devais donner un seul conseil aux futurs candidats : restez concentrés sur votre objectif, travaillez régulièrement et ne vous laissez pas décourager.

Dr Ahmed SIFAOU

Gériatrie — Lauréat EVC 2025 — Voie externe

ÉPREUVES EVC 2026 : À PARTIR DE NOVEMBRE 2026

Commence ta préparation maintenant.

La méthode · L'entraînement · Les formateurs

Rejoins les +9 000 médecins → major-ecn.fr

★ BONUS OFFERT

Accès GRATUIT à l'espace découverte Major ECN :

- QCM calibrés niveau EVC
- Cas cliniques corrigés
- Fiches méthode incluses

Sans engagement

+9 000

médecins

15 ans

d'expertise

Toutes

les spécialités



Scannez → major-ecn.fr

Sources : Roediger & Karpicke (2006) ; Dunlosky et al. (2013) ; Bowen, NEJM, 2006 ; Croskerry, Academic Medicine.